

PHOENIX evaluatiestudie

Fase 1 – onafhankelijke expertgeneratie

Instrument voor Zorgprofessionals

Deelnemerscode: HCP-PRE-02

Toegewezen casussen: **C03** (41-jarige leraar secundair onderwijs) en **C04** (63-jarige gepensioneerde professional)

Studie	Evaluatie van de klinische kwaliteit van een ontologiegebaseerd multi-agentsysteem voor gepersonaliseerde digitale geestelijke gezondheidszorg (PHOENIX)
Instelling	Universiteit Gent – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Onderzoeker	Stijn Van Severen (masterproefstudent)
Promotoren	Prof. Dr. Geert Crombez; Dr. Annick De Paepe
Contact	stijn.vanseveren@ugent.be
Geschatte duur	Ongeveer 35–45 minuten voor beide casussen samen

Doel van deze bundel

U neemt deel aan een evaluatiestudie waarin zorgprofessionals onafhankelijk dezelfde vijf klinische redeneerstappen uitvoeren als het PHOENIX-systeem. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

Voor elk van uw twee casussen vult u dezelfde vijf delen in: (1) operationalisering, (2) initieel observatiemodel, (3) prioritering van behandeldoelen, (4) verfijning van EMA-metingen en (5) een mobiele coachingsboodschap.

We vragen uw eigen klinische oordeelsvorming. Antwoord zoals u dat in een reële professionele context zou doen, maar werk strikt volgens de instructies op de volgende pagina.

Vertrouwelijkheid: uw antwoorden worden voor analyse geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt binnen deze masterproefstudie. Deelname is vrijwillig; u kan zich op elk moment terugtrekken door contact op te nemen met de onderzoeker.

Contents

1	Instructiepagina	3
2	Deel 1: Operationalisering van de mentale gezondheidstoestand	5
3	Deel 2: Initieel observatiemodel (bipartiet netwerk)	8
4	Deel 3: Behandeldoelprioritering via het bipartiet netwerk	11
5	Deel 4: Verfijnd observatiemodel – selectie van sub-predictoren	14
6	Deel 5: Gepersonaliseerde mobiele coachingsboodschap (HAPA-kader)	17
7	Afronding en terugbezorging	20

1 Instructiepagina

Het PHOENIX-systeem en de context van deze studie

PHOENIX (Personalized Hierarchical Optimization Engine for Navigating Insightful eXplorations) is een multi-agentsysteem ontwikkeld als onderdeel van een masterproef in de psychologie aan de Universiteit Gent. Het systeem verwerkt een vrije klachttekst en doorloopt vijf opeenvolgende klinische redeneerstappen die de kern vormen van een gepersonaliseerde, longitudinale digitale interventie.

Het theoretische kader van PHOENIX steunt op het **netwerk-analytisch model van psychopathologie** (Borsboom & Cramer, 2013): psychische klachten worden niet als uitingen van een latente stoornis beschouwd, maar als een *dynamisch netwerk van onderling samenhangende klachtcomponenten*. Een sleutelbegrip daarbinnen is het onderscheid tussen **criteria** (symptoomdimensies die de toestand van de persoon beschrijven) en **predictoren** (modificeerbare variabelen die de criteria causaal beïnvloeden en als behandeldoel kunnen dienen).

Kerndefinities: criterium versus predictor

Criterium (CR): een klinisch relevante, momentaan aanwezige *klacht- of toestandsdimensie* van de persoon die herhaald meetbaar is via dagelijkse EMA. Criteria zijn de *uitkomstvariabelen* in het netwerk – ze beschrijven *wat er mis gaat* (bijv. inslaapproblemen, paniekepisoden, sombere stemming). Criteria zijn geen gedragingen of interventies.

Predictor (P): een *modificeerbare gedrags- of procesvariabele* die plausibel causaal ingrijpt op een of meerdere criteria en dagelijks meetbaar is via een korte EMA-vraag. Predictoren zijn de *ingreepvariabelen* in het netwerk – ze beschrijven *wat veranderbaar is* (bijv. avondschermtijd, geplande exposure, aerobe beweging). Een predictor is *nooit een symptoom zelf*, maar een gedrag, strategie of omgevingsfactor die het symptoom beïnvloedt.

Voorbeelden ter verduidelijking:

- **Criterium:** inslaapproblemen, anticipatieangst, anergie, guilt-driven ruminatie.
- **Predictor:** avondschermtijd (min), geplande exposurestap (ja/nee), bewegingsfrequentie (min), preslaap-offloading (ja/nee).
- **Geen predictor, geen criterium:** eetlust bij avondmaal, rusthartslag, spierspanning – dit zijn symptoom- of toestandsmaten, geen behandelbare predictoren.

Ecological Momentary Assessment (EMA) – basisprincipes

EMA is een methode waarbij personen meerdere keren per dag hun actuele toestand of gedrag rapporteren via een mobiele applicatie. In PHOENIX wordt EMA gebruikt om zowel criteria als predictoren dagelijks te monitoren over een periode van meerdere weken.

Een goede EMA-variabele voldoet aan vier vereisten:

- **Dagelijks rapporteerbaar:** via een korte vraag op de smartphone (ja/nee, aantal, minuten of 0–10).
- **Dynamisch en veranderbaar:** geen vaste trek, diagnose of stabiel achtergrondkenmerk.
- **Klinisch relevant:** toont binnen-persoonsvariatie die therapeutisch informatief is.
- **Onderscheid criterium vs. predictor:** symptoomdimensies zijn criteria; modificeerbare gedragingen zijn predictoren.

Het bipartiet netwerk: structuur van het observatiemodel

Na 21 dagen EMA-monitoring construeert PHOENIX een **bipartiet netwerk**: een graaf met twee kolommen sets en gewogen verbindingen daartussen.

- **Linkse kolom – Predictoren (P)**: de modificeerbare variabelen.
- **Rechtse kolom – Criteria (CR)**: de klacht- en toestandsdimensies.
- **Kanten**: de richting loopt van predictor naar criterium ($P \rightarrow CR$). Een *blauwe* rand duidt op een positief verband (predictor vergroot het criterium), een *rode* rand op een negatief verband (predictor verkleint het criterium). Lijndikte is proportioneel aan de sterkte van het empirische verband uit de monitoringdata.

In **Deel 3** rangschikt u de predictoren op behandelprioriteit op basis van dit netwerk en de monitoringsamenvatting.

Overzicht van de vijf taken

Stap	Klinische taak	Wat u doet	Richttijd
1	Operationalisering	Identificeer 2–6 criteriumlabels (klacht-dimensies)	≈ 6 min
2	Initieel observatiemodel	Genereer 3–5 predictorlabels (modificeerbaar, EMA-geschikt)	≈ 6 min
3	Behandeldoelprioritering	Rangschik alle 5 predictoren van hoog naar laag behandelprioriteit	≈ 7 min
4	Verfijnd observatiemodel	Selecteer exact 6 EMA-items (2 per behandeldoel) uit de lijst van 20	≈ 8 min
5	Mobiele coaching	Schrijf een korte patientgerichte boodschap voor de app	≈ 8 min
Totaal (2 casussen)			35–45 min

Werkwijze – strikt te volgen

1. **Werk sequentieel: Deel 1 → Deel 5.** Ga pas naar een volgend deel wanneer het huidige deel volledig is afgewerkt voor beide casussen.
2. **Gebruik geen generatieve AI, schrijfhulpmiddelen, richtlijnen of collegaoverleg.** Extern gebruik ondermijnt de methodologische validiteit en de blind scoringswaarde van de studie.
3. **Gebruik in latere delen uitsluitend de meegeleverde gestandaardiseerde context.** Die is bewust vastgezet zodat alle deelnemers op identieke input reageren en vergelijkbaar zijn.
4. **Herwerk eerdere antwoorden niet retroactief** nadat u latere context hebt gezien.
5. **Noteer of typ rechtstreeks in de voorziene antwoordzones.** Onleesbare of ambigu geformuleerde antwoorden bemoeilijken latere blinde beoordeling.

2 Deel 1: Operationalisering van de mentale gezondheidstoestand

Instructies Deel 1

Opdracht: identificeer de belangrijkste actuele klacht- en toestandsdimensies (**criteria**) in de klachttekst en noteer voor elke dimensie uitsluitend een **kort criteriumlabel**.

Wat is een criterium? Een criterium is een *symptoom- of klachtdimensie* die beschrijft *wat er mis gaat* bij de persoon. Het is *geen* behandeling, geen gedrag en geen oorzaak, maar een actuele toestandsbeschrijving:

- momenteel aanwezig bij de persoon (niet hypothetisch of anamnestic),
- onderscheidbaar van andere klachtdimensies (niet overlappend),
- in principe herhaald meetbaar via dagelijkse zelfrapportage (EMA).

Voorbeelden van goede criteriumlabels: inslaapproblemen, paniekepisoden, anticipatieangst, sombere stemming, emotionele uitputting, anergie, interpersoonlijke instabiliteit, compulsief controlegedrag.

Let op: gedragingen (bijv. “avondschermtijd”), oorzaken (bijv. “werkstress”) en behandelstrategieën zijn *geen* criteria maar predictoren – die horen in Deel 2.

Antwoordformat: label van 2–5 woorden, zonder beschrijvende zin. Noteer per casus **2–6 criteria**. Laat ongebruikte velden leeg.

Casus 1: 41-jarige leraar secundair onderwijs

“Ik geef al vijftien jaar les en deed dat altijd graag, maar de voorbije maanden voel ik mij volledig leeg. Ik ga naar school, geef mijn lessen en kom thuis, maar er is niets meer over. 's Avonds zit ik voor de televisie en kan ik mij nergens toe aanzetten. Ik ben ook gestopt met afspreken met vrienden en reageer nog zelden op berichten. Op het werk begin ik fouten te maken – dingen vergeten, de draad kwijt raken tijdens een les – wat vroeger nooit gebeurde. Ik schaam mij daarvoor, maar ik weet niet hoe ik dit moet keren.”

Opdracht: noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterium 1 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 2 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 3 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 4 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 5 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 6 Label (2–5 woorden): _____

Casus 2: 63-jarige gepensioneerde professional

“Mijn partner is negen maanden geleden overleden en ik geraak daar nog steeds niet door. Ik denk voortdurend aan hem of haar. Kleine prikkels – een liedje, een geur, een televisieprogramma dat we samen bekeken – lokken intense golven van verdriet uit die ik niet onder controle krijg. Ik slaap slecht; ik word vroeg wakker en raak daarna niet meer in slaap. Daarnaast voel ik veel schuld. Ik blijf maar herhalen wat ik had moeten zeggen of anders had moeten doen. Ik kan mij ook nauwelijks voorstellen hoe mijn toekomst er nog betekenisvol kan uitzien. Mijn familie zegt dat het al beter zou moeten gaan, maar zo voelt het niet.”

Opdracht: noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterium 1 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 2 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 3 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 4 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 5 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 6 Label (2–5 woorden): _____

3 Deel 2: Initieel observatiemodel (bipartiet netwerk)

Instructies Deel 2

Opdracht: genereer **3–5 predictorlabels** die samen het **initieel observatiemodel** voor deze casus vormen.

Wat is een predictor in deze context? Een predictor is een *modificeerbare gedrags- of procesvariabele* die beschrijft *wat de persoon kan veranderen*:

- **Modificeerbaar:** de persoon (of therapeut) kan er rechtstreeks op ingrijpen.
- **EMA-geschikt:** dagelijks meetbaar via een eenvoudige vraag op de smartphone (ja/nee, aantal, minuten of 0–10 schaal).
- **Causaal plausibel:** klinisch aannemelijk dat het predictor de criteria beïnvloedt.
- **Geen criterium:** symptomen, klachtniveaus of diagnostische trekken zijn *geen* predictoren.

Voorbeelden van goede predictorlabels: avondschermtijd, geplande exposure, aerobe beweging, preslaap-offloading, veiligheidsgedrag, werk-privegrens, herstelactiviteit, compulsie-uitstel.

Let op: predictoren als “eetlust”, “spierspanning” of “moeheid” zijn symptoomdimensies (criteria) – geen predictoren. Kies variabelen die de persoon actief kan uitvoeren of aanpassen.

Antwoordformat: enkel een label van 2–6 woorden, zonder meetdefinitie of toelichting. Laat ongebruikte velden leeg.

Casus 1: 41-jarige leraar secundair onderwijs – Deel 2

41-jarige leraar secundair onderwijs; duur: 7 maanden. Emotionele uitputting, professionele depersonalisatie, sociale terugtrekking en cognitieve fouten op het werk.

Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Emotionele uitputting
- **CR-2** Professionele depersonalisatie
- **CR-3** Sociale terugtrekking
- **CR-4** Cognitieve fouten op het werk

Opdracht: noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 2 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 3 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 4 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 5 Label (2–6 woorden): _____

Casus 2: 63-jarige gepensioneerde professional – Deel 2

63-jarige gepensioneerde professional; duur: 9 maanden na overlijden van partner. Aanhoudende rouwreactie, doorslaapinsomnie, schuldgedreven ruminatie en verminderde toekomstorientatie.

Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Aanhoudende rouwreactie
- **CR-2** Doorslaapinsomnie
- **CR-3** Schuldgedreven ruminatie
- **CR-4** Verminderde toekomstorientatie

Opdracht: noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 2 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 3 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 4 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 5 Label (2–6 woorden): _____

4 Deel 3: Behandeldoelprioritering via het bipartiet netwerk

Instructies Deel 3

Opdracht: rangschik de **5 standaardpredictoren** van **hoogste** naar **laagste** behandelprioriteit.

Wat is een behandeldoel? Een behandeldoel is de predictor die, als hij veranderd wordt, naar verwachting de sterkste vermindering van de criteria oplevert. U selecteert op basis van drie criteria:

- a) **Bewijs uit monitoring:** is er in de monitoringdata aanleiding dat deze predictor actief bijdraagt aan de klacht (bijv. hoge frequentie van problematisch gedrag, of bijna afwezigheid van gewenst gedrag)?
- b) **Klinische modificeerbaarheid:** is de predictor realistisch veranderbaar voor deze persoon, gegeven profiel en context?
- c) **Netwerkimpact:** beïnvloedt de predictor meerdere criteria tegelijk (hogere return-on-intervention)?

Het bipartiet netwerk lezen:

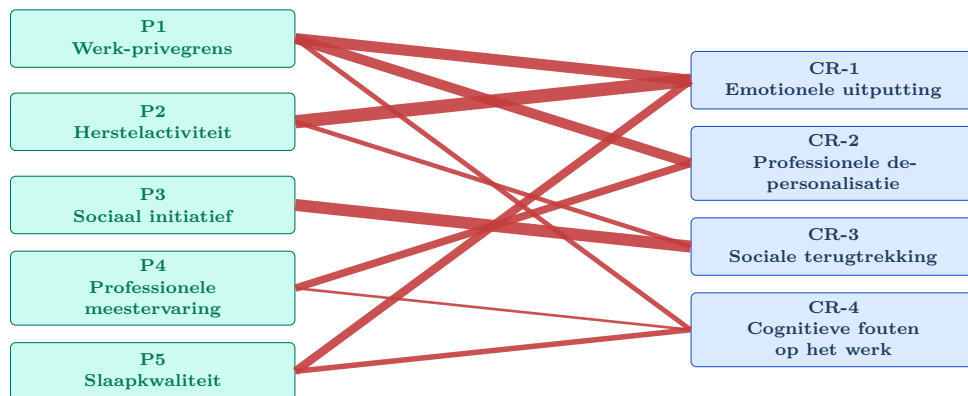
- Predictoren staan in de **linkerkolom (groen)**; criteria in de **rechterkolom (blauw)**.
- **Blauwe rand:** predictor heeft een positief verband met het criterium (hogere predictor → hoger criterium; bijv. meer veiligheidsgedrag → meer angst).
- **Rode rand:** predictor heeft een negatief verband met het criterium (hogere predictor → lager criterium; bijv. meer exposure → minder vermijding).
- **Lijndikte:** proportioneel aan de sterkte van het empirische verband (21-daagse EMA-data).

Antwoordformat: vul alle 5 prioriteitslijnen in, van rangorde 1 (hoogste prioriteit) tot en met 5 (laagste prioriteit).

Casus 1: 41-jarige leraar secundair onderwijs – Deel 3

Emotionele uitputting, professionele depersonalisatie, sociale terugtrekking en cognitieve fouten op het werk. Duur: 7 maanden.

21-daagse monitoring: Werkoverschrijding na werktijd: gem. 5,4 episodes/dag. Herstelactiviteiten: gem. 1,2/week. Sociaal contact op eigen initiatief: gem. 0,7/week. Professionele meestervaringen: gem. 0,9/dag. Slaapkwaliteit: gem. 4,1/10.



— Blauw = positief verband (predictor *vergroot* criterium)
 — Rood = negatief verband (predictor *verkleint* criterium)

Lijndikte proportioneel aan |w|, genormaliseerd binnen netwerk (bereik 1–5 pt).

Opdracht: rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Werk-privegrens, P2: Herstelactiviteit, P3: Sociaal initiatief, P4: Professionele meestervaring, P5: Slaapkwaliteit

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

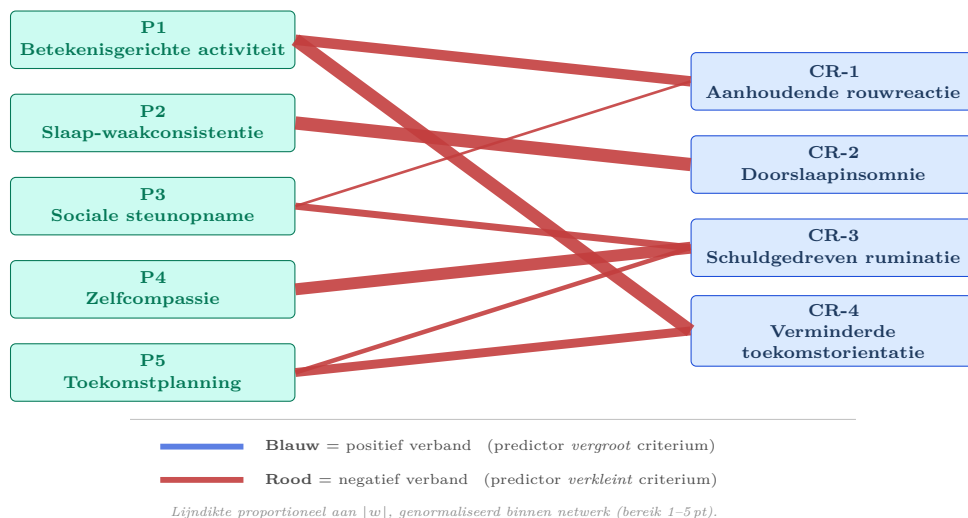
Prioriteit 4

Prioriteit 5

Casus 2: 63-jarige gepensioneerde professional – Deel 3

Aanhoudende rouwreactie, doorslaapinsomnie, schuldgedreven ruminatie en verminderde toekomstoriëntatie. Duur: 9 maanden na overlijden van partner.

21-daagse monitoring: Rouwintrusies: gem. 4,2/dag. Slaapkwaliteit: gem. 2,8/10. Sociale contactmomenten: gem. 3,1/week. Schuldgedachten: gem. 5,8/dag. Toekomstgerichte activiteiten: gem. 0,4/week. Betekenisgerichte activiteit uitgevoerd: 4/21 dagen.



Opdracht: rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Betekenisgerichte activiteit, P2: Slaap-waakconsistentie, P3: Sociale steunopname, P4: Zelfcompassie, P5: Toekomstplanning

Prioriteit 1	
Prioriteit 2	
Prioriteit 3	
Prioriteit 4	
Prioriteit 5	

5 Deel 4: Verfijnd observatiemodel – selectie van sub-predictoren

Instructies Deel 4

Opdracht: selecteer per casus **exact 6 EMA-items: 2 sub-predictoren per behandeldoel** (3 behandeldoelen $\times$ 2 = 6 items).

Wat zijn sub-predictoren? Een behandeldoel uit Deel 3 (bijv. “geplande exposure”) is een conceptueel label. In de volgende EMA-cyclus moet dit label vertaald worden naar *concrete, dagelijks meetbare gedragsitems* – de **sub-predictoren**. Elke sub-predictor is een specifieke operationalisering van het behandeldoel als dagelijkse EMA-vraag.

Voorbeeld: behandeldoel = *avondschermtijd* → sub-predictor 1: “smartphone-gebruik na 22.00 uur (min)” → sub-predictor 2: “schermvrij interval voor slapengaan (min)”

Belangrijk: alle 20 items in de lijst zijn **predictor-type EMA-items** (modificeerbare gedragingen en strategieën – *geen* symptomen of klachtdimensies). Uw taak is te selecteren welke 6 items het best aansluiten bij de 3 gestandaardiseerde behandeldoelen, 2 per doel.

Selectieprincipe:

- Kies per behandeldoel de 2 items die dat doel het meest direct en precies meten.
- Verkies items die samen een compleet beeld geven van het behandeldoel (bijv. frequentie *en* duur, of twee complementaire gedragingen).
- Vermijd items die het behandeldoel slechts zijdelings raken.

Antwoordformat: vink **exact 6** items aan. Geen toelichting vereist.

Casus 1: 41-jarige leraar secundair onderwijs – Deel 4

Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:

1. **Werk-priviegrens** (*sterkste onderhoudende factor voor uitputting; frequente overschrijding na werktijd*)
2. **Herstelactiviteit** (*kritisch laag niveau (1,2/week); relevant voor CR-1 en CR-3*)
3. **Professionele meestersvaring** (*kan depersonalisatie temperen en dag-tot-dag positieve variatie benutten*)

Opdracht: selecteer **exact 6** EMA-items (2 per behandeldoel) die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Bewust sociaal contact geïnitieerd buiten werkverband (ja/nee)
2. ☐ Werkmail of -berichten bewust niet gecheckt na 18.00 uur (ja/nee)
3. ☐ Bewust contact met collega of leerling buiten leslokaal gezocht (ja/nee)
4. ☐ Werkgerelateerde gedachten actief afgesloten na werktijd via een vaste afsluiting (ja/nee)
5. ☐ Cafeïne-inname na 15.00 uur (aantal)
6. ☐ Maaltijd als zelfzorgmoment bewust genuttigd op vaste tijd (ja/nee)
7. ☐ Ochtendactiviteit voor aanvang werk uitgevoerd (bijv. wandeling, yoga) (min)
8. ☐ Herstelactiviteit buiten het werk actief uitgevoerd (min)
9. ☐ Consistent slaaptijdstip aangehouden (ja/nee)
10. ☐ Bewuste stap gezet om werkachterstand te reduceren (ja/nee)
11. ☐ Herstelactiviteit ingepland voor de komende week (ja/nee)
12. ☐ Lichaamsbeweging als herstelactiviteit na werk uitgevoerd (min)
13. ☐ Alcoholinname vanavond (eenheden)
14. ☐ Moment van professionele positieve prestatie bewust opgemerkt en genoteerd (ja/nee)
15. ☐ Schermtijd in de late avond bewust beperkt (min)
16. ☐ Aantal nieuwschecks in de avond beperkt tot maximum (aantal)
17. ☐ Professionele vaardigheid of aanpak bewust en succesvol ingezet (ja/nee)
18. ☐ Waterinname vandaag (glazen)
19. ☐ Aantal lessen vandaag (uren)
20. ☐ Digitale ontgiftiging (schermvrij uur in de avond) toegepast (ja/nee)

Totaal geselecteerd: _____ / 6

Casus 2: 63-jarige gepensioneerde professional – Deel 4

Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:

1. **Betekenisgerichte activiteit** (*slechts 4/21 dagen uitgevoerd; hoog potentieel voor CR-1 en CR-4*)
2. **Slaap-waakconsistentie** (*lage slaapkwaliteit ondermijnt emotieregulatie en rouwverwerking*)
3. **Zelfcompassie** (*schuldgedreven ruminatie is hoog en vraagt een direct corrigerend proces*)

Opdracht: selecteer **exact 6** EMA-items (2 per behandeldoel) die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Wandeling of lichte beweging buiten uitgevoerd (min)
2. ☐ Familielid of vriend bewust gecontacteerd vandaag (ja/nee)
3. ☐ Activiteit die een waarde of herinnering vertegenwoordigt uitgevoerd (ja/nee)
4. ☐ Cafeïne-inname na 17.00 uur (aantal)
5. ☐ Schermtijd na 21.00 uur bewust beperkt (min)
6. ☐ Duur van betekenisvolle of waardegerichte bezigheid vandaag (min)
7. ☐ Maaltijd bereid en op vaste tijd bewust genuttigd (ja/nee)
8. ☐ Opstaan op vast waktijdstip aangehouden (ja/nee)
9. ☐ Ontspanningsoefening of rustige activiteit in de avond uitgevoerd (min)
10. ☐ Alcoholinname vanavond (eenheden)
11. ☐ Afwijking van gewone slaap- of waktijdstip (min)
12. ☐ Bewuste omgang met herinneringsvoorwerpen of -momenten (ja/nee)
13. ☐ Waterinname vandaag (glazen)
14. ☐ Zelfkritische gedachte bewust omgevormd naar mildere formulering (ja/nee)
15. ☐ Sociale activiteit buiten huis bewust bijgewoond (ja/nee)
16. ☐ Lichte lichaamsbeweging voor mobiliteit en welzijn (min)
17. ☐ Zelfcompassie-oefening of zelfondersteunende tekst bewust toegepast (min)
18. ☐ Consistent waktijdstip aangehouden 's ochtends (ja/nee)
19. ☐ Middagdutje genomen (ja/nee)
20. ☐ Vrijwilligerswerk of helpende activiteit voor anderen (min)

Totaal geselecteerd: _____ / 6

6 Deel 5: Gepersonaliseerde mobiele coachingsboodschap (HAPA-kader)

Instructies Deel 5

Opdracht: schrijf een korte, rechtstreeks tot de persoon gerichte coachingsboodschap die in de mobiele applicatie verschijnt.

Theoretisch kader – HAPA: PHOENIX gebruikt het **Health Action Process Approach (HAPA; Schwarzer, 1992)** om de boodschap af te stemmen op de motivationele fase van de persoon:

- **Pre-intentionele fase:** de persoon is nog niet gemotiveerd om te veranderen → focus op risicobewustzijn en uitkomstverwachting.
- **Intentionele fase:** de persoon wil veranderen maar heeft nog geen concreet plan → focus op doelstelling en actieplanning.
- **Actie-/onderhoudsfase:** de persoon probeert al te veranderen → focus op copingplanning en zelfeffectiviteitsondersteuning.

U hoeft de fase niet expliciet te benoemen; gebruik het kader om de toon en inhoud van uw boodschap te sturen.

De boodschap voldoet aan:

- **Lengte:** 2–4 zinnen, compact genoeg voor een mobiel scherm.
- **Toon:** warm, direct, professioneel – geen klinisch jargon of diagnostische labels.
- **Inhoud:** adresseert het primaire behandeldoel en de voornaamste barriere; bevat een concrete, eerstvolgende actie.
- **Perspectief:** tweede persoon (“jij” of formeel “u”).

Werkvoorbeeld (niet gerelateerd aan een studiecaser):

Context: verpleegkundige; behandeldoel = korte beweegmomenten inbouwen; barriere = vermoeidheid na de shift (lage zelfeffectiviteit); fase = intentioneel.

Voorbeeldboodschap:

“Na een zware shift voelt rust nemen logisch, maar net dat eerste kleine beweegmoment kan je avond helpen ontladen. Trek vanavond meteen na thuiskomst je schoenen aan en wandel 10 minuten buiten – niet meer dan dat ene blokje. Zo maak je de stap haalbaar en vergroot je de kans dat je lichaam later echt kan afschakelen.”

Casus 1: 41-jarige leraar secundair onderwijs – Deel 5

Primair probleem

Uitgesproken werkgerelateerde uitputting met verlies aan betekenis en toenemende sociale terugtrekking.

Behandeldoel

Een duidelijke werk-priviegrens installeren en na het werk consequent herstelgedrag activeren.

Voornaamste barriere

Actieplanning ontbreekt: er is geen concreet moment of signaal waarop de werkmodus stopt.

Copingstrategie

Koppel een vaste afsluitsignalering aan een kleine herstelactiviteit die onmiddellijk na het einde van de werkdag start.

Opdracht: schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

Casus 2: 63-jarige gepensioneerde professional – Deel 5**Primair probleem**

Aanhoudende rouw met uitgesproken schuldbeleving en weinig toekomstgerichte betrokkenheid.

Behandeldoel

Een kleine maar betekenisvolle activiteit plannen die verbinding maakt met herinnering en toekomst.

Voornaamste barriere

Motivationele inertie: de eerste stap voelt zinloos of emotioneel te zwaar.

Copingstrategie

Verklein de instap naar een tijdsafgebakende micro-actie, bijvoorbeeld een korte schrijfoefening of een vast herinneringsmoment.

Opdracht: schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

7 Afronding en terugbezorging

Dank u voor het invullen van alle vijf delen voor uw twee toegewezen casussen (Casus 1 en Casus 2).

Checklist voor terugbezorging

- ☐ Ik heb in Deel 1 voor beide casussen criteriumlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 2 voor beide casussen predictorlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 3 voor beide casussen alle 5 predictors gerangschikt.
- ☐ Ik heb in Deel 4 voor beide casussen exact 6 EMA-items geselecteerd.
- ☐ Ik heb in Deel 5 voor beide casussen een mobiele coachingsboodschap geschreven.
- ☐ Mijn antwoorden weerspiegelen mijn eigen klinische oordeel zonder gebruik van generatieve AI of andere externe hulp.
- ☐ Ik begrijp dat mijn antwoorden geanonimiseerd worden voor analyse.

Bezorg het ingevulde document terug via e-mail aan:

`stijn.vanseveren@ugent.be` met onderwerp: PHOENIX-PRE-HCP-PRE-02

Na ontvangst worden uw antwoorden geanonimiseerd en opgenomen in het expertreferentiecorpus voor de latere blind evaluatie van PHOENIX. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit onderzoek.